

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231570295 | 396

ALEXANDRE SANTOS SILVA

IDADE: 54 | PESO: 84 | ALTURA: 1,60 | PROFISSÃO: Engenheiro

SINTOMAS: Roncos, engasgos presenciados, sonolência diurna, cansaço

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Duvelapaxina 150 / Plavix 20g / Uexge Hct 8/12,5

Ne bilite

MÉDICO: Dra Sandra Sales

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana (personal)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20:30-21h

HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 6h30m

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: raramente

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 69,5cm SPO2: 66%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS

CIRURGIAS: (S) NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 CI/CPAP: 80% PRESSÃO NO EXAME:

max. N30

10/10/24 Avaliação

17/10/24 P= 109cmH₂O

IAH= 7,7cmH₂O

m de uso: 7h 56'

fuga: 6,4l/min

Relata-se sentir o bem

adaptando-se um ~~ao~~ relação

ao uso da máscara

Ajuste P= 8-14cmH₂O

Natacha

01/11/24 P= 12,4cmH₂O

IAH= 5,7cmH₂O (A0)

m de uso= 7h 20min

fuga= 11l/min

4 rampas 5cmH₂O

4 auto 8 à 15cmH₂O

Sina

11/11 P= 12,8cmH₂O

IAH= 5,9cmH₂O

M. de uso: 7h40'

- Bom adapt.

- Fixo a pressão em 13cmH₂O

24

02/12
2024 P=13 cmH₂O
IAH= 4,7 elh
m de uso: 7h47min
fuga: 10 l/min

→ sente bem
Bem adaptado

Silvia
7.

10/12/24 P=13 cmH₂O
IAH= 7,8 elh
m de uso: 6h54'
fuga: 17 l/min

Bem adaptado
Comprou CPAP Elite
Natacha

10/03/25 P=13 cmH₂O
IAH: 5,5 elh
m de uso: 7h40'
fuga: 10 l/min

Bem adaptado
Siquieiros
Natacha

14/03/25 P=13 cmH₂O
IAH= 4,7 elh
m de uso: 7h46'
fuga:

Bem adaptado
Natacha

20/05
25 P=13 cmH₂O
IAH: 3,5 elh
m de uso: 7h14'
fuga: 19,9 l/min

Bem adaptado
Siquieiros

Natacha

01/08
25 P=13 cmH₂O
IAH= 2,0 elh
m de uso: 8h
fuga: 23,9 l/min

Natacha

EXAME DE POLISSONOGRAFIA - CPAP

Nome: Alexandre Santos Silva

Sexo: M

Idade: 54 anos

Peso: 84 Kg

Altura: 1,60 m

Exame: 051

Data do Exame: 24/08/2024

CONCLUSÃO

Realizada titulação de CPAP através de Polissonografia concomitante da pressão de ar necessária no aparelho para eliminação de Apnéia/Hipopnéia e correção de dessaturação é de 9 cm iniciando em 4 cm H₂O com rampa de 35 minutos.

Sandra Salles Pinheiro Pereira

Dra. Sandra Salles Pinheiro Pereira

Neurologia

CRM 52 20983/0

RQE - CFM 13516

EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: Alexandre Santos Silva (C.R.O.)

Exame: 2907

Sexo: M Idade: 54 anos

Peso: 84 Kg Altura: 1,60 m IMC: 32,8 Kg/m²

Data do Exame: 24/8/2024

COMENTÁRIOS:

Polissonografia de noite inteira realizada em boas condições técnicas, tendo início às 21:09:05 horas e término às 5:45:37 horas, com latência para o sono não-REM de 18,0 minutos e latência para o sono REM de 0,0 minutos. O tempo total de sono foi de 370,0 minutos, com eficiência de 71,6%. A distribuição do sono mostrou 0,0% de estágio N1, 86,5% de estágio N2, 13,5% de estágio N3 (sono de ondas lentas) e 0,0% de sono REM. O tempo de vigília após o início do sono (WASO) foi 147,0 minutos. Despertares (18) e micro-despertares (5) com índice de 3,7/hora. O índice de apnéia-hipopnéia foi 20,3/hora, sendo 20,3 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora. O número de eventos respiratórios foi de 125, sendo 125 obstrutivos, 0 centrais e 0 mistos. O índice de transtorno ventilatório (ITV - índice de apnéia + hipopnéia + rera) foi de 20,3/hora e o número de Rera foi 0. A duração máxima das apnéias e hipopnéias foi de 32,3 segundos. Apnéias e hipopnéias predominaram durante o estágio 2 do sono não-REM (índice de 17,7/hora) e estágio REM (índice de 0,0/hora). Roncos foram anotados 147 vezes, com índice de 23,8/hora. A saturação basal da oxihemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 94,0%, a maior de 98% e a mínima de 85%, permanecendo 2,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0% do tempo com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 19 dessaturações da oxihemoglobina. A SATO2 ficou 8,9 minutos abaixo de 90%. Houve 0 PLM (índice de 0,0/hora), e 0 movimentos de membros inferiores (índice de 0,0/hora).

CONCLUSÃO

1. Índice de eventos respiratórios moderadamente elevados com predomínio de apnéias obstrutivas acompanhadas de dessaturações da oxihemoglobina frequentes e mantidas.
2. Eficiência do sono reduzida devido ao período prolongado de permanência acordado após o adormecer.
3. Arquitetura do sono alterada com aumento do sono superficial, redução do sono profundo e ausência do sono REM.
4. Presença de roncos.
5. EEG sem alterações significativas.

Dra. Sandra Salles Pinheiro Pereira

Neurologia

CRM-RJ 5220983-0

RQE-CFM 13516